

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085735-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA PESENTI DA SILVA

PROCESSO CIVIL E SAÚDE - CONSULTA EM ONCOLOGIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA ANTE A PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS - ART 300 DO CPC - PRAZO LEGAL PARA O PRIMEIRO TRATAMENTO ULTRAPASSADO - AGRAVO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5085735-04.2024.4.02.5101

510014903668 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085735-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA PESENTI DA SILVA

RELATÓRIO

A presente **MEDIDA DE URGÊNCIA** foi interposta pela União, buscando a reforma da decisão proferida pelo Juizado Especial Federal de origem que deferiu em parte pedido de antecipação de tutela para determinar consulta em oncologia. Eis a decisão:

"(...)

Firmadas essas premissas, embora ainda não tenha sido verificada a ultrapassagem do prazo máximo normativo - de 60 dias, repise-se - para o fornecimento da consulta e dos demais tratamentos oncológicos necessários, tamanha espera não se coaduna com a situação da paciente.

*Nesse aspecto, convém observar que o médico que acompanha a autora (1.2, página 8) asseverou que, apesar de se tratar de diagnóstico recente, há muita chance da paciente responder ao tratamento quimioterápico. Inclusive, destacando-se a urgência do caso, devendo iniciar o tratamento assim que possível, **"com o risco de morte em poucas semanas, caso não o faça"**.*

*Ademais, convém destacar a classificação de **risco vermelho** do quadro em questão, agravada especialmente pela sua posição na fila de espera (nº 335), que é absolutamente incoerente com a gravidade do caso.*

Evidenciam-se, dessarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), em razão dos riscos à saúde da parte autora que a demora do processamento pode provocar, além da probabilidade quanto ao direito, atribuída ao princípio de prova acerca da situação médica da parte autora, sobretudo porque, de acordo a Lei 12.732/12, os pacientes acometidos de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado, quando decorrido o prazo de 60 dias, previsto nas normas acima mencionadas, o que se verifica no caso concreto.

"(...)

Ante todo o exposto, nos moldes do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para determinar que os réus, solidariamente, de acordo com as suas atribuições previstas nos atos normativos vigentes, adotem os procedimentos necessários para que a autora

seja submetida à consulta ambulatorial 1ª vez – coloproctologia (oncologia), bem como posterior tratamento oncológico compatível com seu quadro, de acordo com as suas necessidades clínicas.

(...)”.

A União, irresignada, assevera a necessidade se observar a fila de espera, ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ausência de perícia médica realizada por especialista e ilegitimidade passiva da União.

A decisão de 1ª instância foi mantida por atender aos parâmetros legais.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

O parecer NAT do evento 6, PARECER1 dos autos originários expõe que:

Trata-se de Autora, de 69 anos de idade, com **adenocarcinoma de cólon direito e múltiplas metástases hepáticas**, apresentando **ascite volumosa com edema de membros inferiores** (Evento 1, ANEXO2, Página 8). Foi encaminhada à **consulta ambulatorial em oncologia clínica** (Evento 1, ANEXO2, Página 13). Foram pleiteados **consulta em oncologia e tratamento oncológico** (Evento 1, INIC1, Página 7).

Informa-se que a **consulta em oncologia** e o **tratamento oncológico** pleiteados **estão indicados** ao manejo do quadro clínico apresentado pela Autora (Evento 1, ANEXO2, Páginas 8 e 13).

É interessante registrar que o posterior **tratamento** será determinado pelo médico especialista na **consulta em oncologia**, conforme a necessidade do Requerente.

Considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), informa-se que a consulta e o tratamento pleiteados **estão cobertos pelo SUS**, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), na qual constam: **consulta médica em atenção especializada, tratamento clínico de paciente oncológico e tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades oncológicas**, sob os respectivos códigos de procedimento: 03.01.01.007-2, 03.04.10.002-1 e 03.03.13.006-7.

No intuito de identificar o correto encaminhamento da Suplicante aos sistemas de regulação, este Núcleo consultou a plataforma do **Sistema Estadual de Regulação – SER (ANEXO II)** e verificou que ela foi inserida em **27 de agosto de 2024 para ambulatório 1ª vez – coloproctologia (oncologia)** com classificação de risco **vermelho** e situação **em fila**, sob a responsabilidade da central REUNI-RJ.

Adicionalmente, informa-se que em consulta à Lista de Espera da Regulação – Ambulatório da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (ANEXO III), verificou-se que a Suplicante se encontra na **posição nº 335**, da fila de espera para **ambulatório 1ª vez – coloproctologia (oncologia)**.

Cabe esclarecer que, **no âmbito do SUS**, para o acesso ao tratamento oncológico, **é necessária, primeiramente, a realização de uma consulta de 1ª vez no ambulatório da especialidade correspondente**.

Desta forma, entende-se que **a via administrativa está sendo utilizada** no caso em tela, **sem a resolução da demanda pleiteada até o presente momento**.

Em consulta ao banco de dados do Ministério da Saúde³ foram encontradas as **Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Câncer de Cólon e Reto**, nas quais consta que “... **Doentes com diagnóstico de câncer colorretal devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento** ...”.

Conforme informações médicas de fls. 8-13 do evento 1, ANEXO2 dos autos de origem, trata-se de Autora, de 69 anos de idade, com adenocarcinoma de cólon direito e múltiplas metástases hepáticas, apresentando ascite volumosa com edema de membros inferiores. Foi encaminhada à consulta ambulatorial em oncologia clínica. **Segundo o NAT, a autora foi inserida em 27 de agosto de 2024 para ambulatório 1ª vez - coloproctologia (oncologia) com classificação de risco vermelho.** O documento médico de fl. 8 do evento 1, ANEXO2 atesta que ***“a situação é emergencial, devendo iniciar a terapia antineoplásica imediatamente, com o risco de morte em poucas semanas, caso não o faça. A qualidade de vida da paciente está deteriorando à cada dia, sendo considerada prioritária para iniciar a quimioterapia específica”.*** **Todavia, a autora está na posição 335 da fila de espera para 1º atendimento.**

A Lei nº 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada, estabelece em seu artigo 2º:

“Art. 1º O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei.

Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados.

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3º Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei nº 13.896, de 2019) "

Transcorrido o prazo máximo de 60 dias fixado pela Lei nº 12.732/2012 sem o início do primeiro tratamento, presume-se negligência e falha no serviço da Administração Pública, apta a autorizar a intervenção judicial, pois evidencia a probabilidade do direito, na forma do art. 300 do CPC/2015.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal obriga o Poder Público a garantir o direito dos cidadãos à saúde, mediante políticas sociais e econômicas. Portanto, é possível a intervenção judicial para garantir este direito ao cidadão, quando houver falha do Estado.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo a tutela e indeferindo o efeito suspensivo pretendido.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.